Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
et de la Protection sociale

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

Système d'information relatif à la Santé de la Reproduction, Santé de l'Enfant et Soins Curatifs
SREC

SANTE DE LA REPRODUCTION, SANTE DE L'ENFANT ET SOINS CURATIFS

Définitions et concepts

Direction de la Planification et des Ressources Financières
Division de la Planification et des Etudes
Service des Etudes et de l'Information Sanitaire

Table des matières

1. PLANIFICATION FAMILIALE / CONTRACEPTION 3
1.1. Performances 3
1.2. Ressources 4
2. DETECTION PRECOCE DES CANCERS DU SEIN ET DU COL DE L'UTERUS 5
3. SANTE DE LA MERE 8
3.1. Consultation prénatale 8
3.2. Consultation en Post Natal 10
3.3. Accouchement et suite de couches 13
4. VACCINATION 19
4.1. Performances 19
4.2. Ressources 21
4.3. Calendrier National de Vaccination des Enfants de moins de 5 ans 21
5. NUTRITION 22
5.1. Performances 22
5.2. Courbes de croissance 22
5.3. Calendrier de supplémentation des enfants de moins de 5 ans 24
5.4. Ressources 25
6. CONSULTATION MEDICALE DE L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS 26
7. IST SIDA 31
7.1. Déclaration syndromique des cas d'IST 31
7.2. Surveillance de la syphilis chez la femme enceinte et nouveau-né 32
7.3. Dépistage du VIH 32
7.4. Elimination de la transmission mère-enfant du VIH/syphilis congénitale – centre réfèrent- 33
8. SANTE DES MIGRANTS 33
9. SOINS CURATIFS 34
9.1. Consultation curative 34
9.2. Infertilité du couple 35
9.3. Santé mentale 36
9.4. RAA 39
9.5. Violence 39
10. SUIVI DES MALADIES CHRONIQUES – DIABETE ET HTA- 40
10.1. Diabète 40
10.2. HTA 40
10.3. Complication 41
10.4. Traitement 42

1. PLANIFICATION FAMILIALE / CONTRACEPTION

1.1.Performances

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
NOUVELLE CLIENTE DU PNPF	Une **Nouvelle cliente du PNPF** est définie comme étant une femme qui opte pour l'utilisation de la contraception moderne, pour la première fois indépendamment du lieu d'approvisionnement.
NOUVELLE CLIENTE POUR UNE METHODE CONTRACEPTIVE ET CLIENTE DE RETOUR	Une **nouvelle cliente** pour une méthode contraceptive donnée, est une femme qui a commencé à utiliser cette méthode pour la première fois. Elle devient **cliente de retour** si elle persiste à l'utiliser et le sera à chaque contact avec le service de santé dans le cadre du Programme National de Planification Familiale. Si elle abandonne temporairement cette méthode, sans en choisir une autre, pour la reprendre après, elle reste **cliente de retour** sauf si la durée de l'abandon réel dépasse les 12 mois ou si une grossesse est intervenue (dans ce dernier cas, elle redevient **nouvelle cliente** soit pour une même méthode, soit pour une autre).
METHODES CONTRACEPTIVES	- Pilules : COC *(Contraception Orale Combinée)* et PMP *(Pilule MicroProgestative),* - DIU (Dispositif Intra-Utérin), - Condoms / préservatifs dans le cadre de la contraception, - Progestatifs Injectables, - Implant contraceptif, - PCU (Pilule Contraceptive d'Urgence), - Ligature des trompes (LT).
CLIENTES AYANT BENEFICIECIE DE LA PCU	Il s'agit des femmes qui ont reçu de la PCU au niveau de l'établissement sanitaire en cas de viol ou autres situations. En cas de non disponibilité de cette méthode au niveau de l'ES, la prescription est nécessaire pour un provisionnement en privé mais ne doit pas être comptabilisé dans la fiche mensuelle comme approvisionnement par l'ES.
PERSONNES AYANT BENEFICIE DE CONDOMS (IST)	Il s'agit de toute personne ayant été approvisionné en préservatif masculin par l'ES dans le cadre d'une IST.
FEMMES DIAGNOSTIQUEES POUR UN PROBLEME DE SANTE DE LA REPRODUCTION	Il s'agit des cas diagnostiqués lors de la prestation de la Planification Familiale (nouvelle cliente ou cliente de retour).
LIGATURE DES TROMPES (LT)	La **Ligature des Trompes** est pratiquée par Célioscopie ou Mini laparotomie ou au cours d'une césarienne. Elle se pratique au niveau d'un hôpital.

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
REFERENCE	La **Référence**, il s'agit de l'acte "référer", envoyer une personne, qui présente un problème de santé de reproduction, à un établissement sanitaire de plus haute technicité en vue, par exemple, d'insérer un D.I.U, un Implant contraceptif ou de subir une L.T.
PRESCRIPTION	La **Prescription** est établie pour une méthode non disponible au niveau de l'établissement sanitaire et jugée utile pour la santé de la femme. Elle est prescrite par le prestataire de service pour qu'elle soit procurée au niveau de la pharmacie.
FEMMES AYANT UN PROBLEME DE MENOPAUSE	Pour une première consultation pour un problème de ménopause, la femme est comptabilisée comme un « nouveau cas. Pour les consultations de suivi, elle est comptabilisée comme « ancien cas ».

1.2.Ressources

PRODUITS DISTRIBUES		UNITES DE GESTION
PILULE	**COC**	Cycle
	PMP	Cycle
CONDOMS	**PF**	Unité
	IST	Unité
DIU		Unité
PROGESTATIFS INJECTABLES		Unité
PCU		Dose

2. DETECTION PRECOCE DES CANCERS DU SEIN ET DU COL DE L'UTERUS

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
DETECTION PRECOCE DES CANCERS	**La détection précoce** des cancers est l'implantation organisée et systématique d'interventions qui comprennent **le dépistage, le diagnostic précoce et le traitement** qui s'en suit. L'offre de soins proposée, concernant la détection précoce et la prise en charge des cancers du sein et du col utérin, s'organise en trois niveaux : - Niveau primaire (Centres de santé urbains et ruraux) : c'est le niveau du dépistage où se fera l'inspection visuelle du col utérin avec l'acide acétique (IVA) et l'examen clinique des seins. - Niveau intermédiaire (Centre de Référence de la Santé de la Reproduction) : c'est le niveau de la confirmation du diagnostic (Radiologie, colposcopie, microbiopsie du sein et biopsie du col utérin) de la prise en charge thérapeutique pour les lésions précancéreuses du col utérin (Résection à l'Anse Diathermique et thermocoagulation). - Niveau secondaire (Hôpitaux provinciaux avec les maternités) : c'est le niveau où se fera le bilan d'extension. La prise en charge thérapeutique se fera selon le degré de gravité des lésions dépistées. (Réunions de Consensus Pluridisciplinaires). - Niveau tertiaire (maternités universitaires et centres d'oncologie) : C'est le niveau de recours pour assurer la prise en charge des formes de cancer nécessitant une prise en charge spécialisée : chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie ou hormonothérapie.
DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN	- La population cible pour le dépistage du cancer du sein est représentée par toutes les femmes âgées de 40 ans à 69 ans révolus et les femmes ayant un antécédent familial de cancer du sein (grand-mère, mère, tante, sœur). Sont exclues du programme toutes les femmes ayant déjà eu un cancer du sein. - Le test de dépistage retenu est l'examen clinique des seins. Il doit être effectué par un professionnel de santé au niveau des centres de santé urbains et ruraux avec ou sans module d'accouchement. Ce test doit être refait tous les deux ans si le résultat du test antérieur est négatif.
DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTERUS	- La population cible pour le dépistage du cancer du col de l'utérus concerne toutes les femmes âgées de 30 ans à 49 ans révolus. Sont exclues du programme, les femmes ayant déjà eu un cancer du col de l'utérus et les femmes enceintes à partir de la 8ème semaine d'aménorrhée jusqu'à la 6ème semaine du post partum. - Le test de dépistage retenu est l'Inspection Visuelle du col utérin avec l'Acide acétique (IVA). Le test sera effectué au niveau des centres de santé urbains et ruraux avec ou sans module d'accouchement par un professionnel de santé dûment formé. Le test doit être refait tous les trois ans quand le résultat est négatif.

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
TESTS DE DEPISTAGE DES CANCERS DU SEIN ET DU COL UTERIN RETENUS	- **L'examen clinique des seins et l'inspection visuelle du col utérin avec l'acide acétique** sont les tests de dépistage des cancers du sein et du col utérin retenus par le Programme National de Détection Précoce des Cancers du Sein et du Col de l'Utérus. Ils sont acceptables, fiables et peu onéreux. - **Inspection visuelle du col avec acide acétique** : C'est un examen gynécologique avec un spéculum lors duquel le médecin ou l'infirmière applique de l'acide acétique dilué (à 3-5%) sur le col utérin.
MAMMOGRAPHIE	Examen radiologique des seins, elle permet de détecter certaines anomalies de la glande mammaire. Son but principal est le diagnostic des lésions et pathologies du sein.
COLPOSCOPIE	Etude de la morphologie du col de l'utérus et du vagin par l'intermédiaire d'un colposcope (appareil optique grossissant). Son but est de rechercher des lésions inflammatoires, précancéreuses ou cancéreuses.
LESIONS INTRA-EPITHELIALES (OU DYSPLASIE DU COL)	Ce sont des lésions qui n'ont pas franchi la membrane basale. Elles précèdent l'apparition du cancer invasif du col. Selon la classification de Richart, il y a trois grades de sévérité : - CIN I = dysplasie légère ; - CIN II = dysplasie modérée ; - CIN III = dysplasie sévère - carcinome in situ.
THERMOCOAGULATION	Traitement destructif du néoplasie intraépithélial basé sur l'application, pendant 20 à 40 secondes, d'une sonde métallique réutilisable, chauffée électriquement à environ 100 °C, conduisant à la destruction épithéliale et stromale de la lésion. Les indications pour l'utilisation de la thermocoagulation : - La thermocoagulation est indiquée pour le traitement des lésions intraépithéliales du col utérin de bas grade qui correspondent à un score de Swede allant de 0 à 5 avec une zone de transformation de type 1 et dont la superficie est inférieure à 75 % de la surface de l'exocol ; - Les femmes présentant des LIE de haut grade correspondant à un score de Swede de 6 et plus et /ou une zone de transformation de type 2 ou 3 et/ou une superficie supérieure à 75 % de la surface de l'exocol ne sont pas éligibles à la thermocoagulation. Elles seront traitées par une technique d'exérèse à savoir la résection à l'anse diathermique (CRSR) ou la conisation à froid (hôpital).
RESECTION A L'ANSE DIATHERMIQUE (RAD)	C'est une intervention qui consiste en l'ablation de la zone de dysplasie au niveau du col avec une anse diathermique (Instrument muni d'un fil métallique dans lequel circule un courant électrique qui incise la lésion à détruire au niveau du col de l'utérus). Les indications pour l'utilisation de la RAD :

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
	- Pour les femmes porteuses d'une lésion non éligible à la thermocoagulation, leur traitement doit être obligatoirement assuré par un gynécologue selon une technique d'exérèse à savoir une RAD ou une conisation au bistouri ; - Vu les contraintes posées par la réalisation de la RAD au niveau du CRSR, cette technique doit être réalisée par un médecin gynécologue soit au bloc opératoire soit au CRSR selon les conditions de chaque région.
POPULATION CIBLE POUR LE DEPISTAGE DES CANCERS DU SEIN ET DU COL DE L'UTERUS	Cancer du sein : - Femmes âgées de 40 à 69 ans ; - Femmes avec ATCD familiaux du Cancer du sein. Cancer du col de l'utérus : - Femmes âgées de 30 à 49. **Femme examinée pour la première fois (sein / col de l'utérus)** : femme de la population cible n'ayant jamais participé au dépistage (sein / col de l'utérus) auparavant. **Femme de retour :** Cancer du sein : femme de la population cible ayant déjà participé au dépistage du cancer du sein au moins 2 ans auparavant ; Cancer du col de l'utérus : femme de la population cible ayant déjà participé au dépistage du cancer du col utérin au moins 3 ans auparavant.

3. SANTE DE LA MERE

3.1.Consultation prénatale

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
NOUVELLE INSCRITE (NI)	Chaque femme enceinte se présentant pour la première fois à la consultation prénatale (CPN) est une "Nouvelle Inscrite (NI)" quel que soit son stade de grossesse.
ANCIENNE INSCRITE (AI)	A partir de la deuxième visite au cours d'une même grossesse, la patiente est dite "Ancienne Inscrite (AI) ".
CONSULTATION PRENATALE	La consultation prénatale est une consultation clinique. Elle permet une prise en charge globale de la femme enceinte et du fœtus par un personnel qualifié.
MODELE DE LA CPN GENERALISE (4 CPN)	Les soins prénatals basé sur quatre consultations : - Premier consultation prénatale : effectuée entre 12 et 15 Semaines d'Aménorrhées (SA) ; - Deuxième consultation prénatale : effectuée vers 24 SA (entre 24-28 SA) ; - Troisième consultation prénatale : effectuée le 8ème mois de grossesse (entre 32-34 SA) ; - Quatrième consultation prénatale : effectuée le 9ème mois de grossesse au-delà de 36 SA. - Autres consultations : toutes consultations qui s'effectuent en dehors du calendrier des CPN préconisées (selon les SA par CPN).
CPN MEDICALISEE	CPN ayant eu recours / faite par un médecin.
METRORRAGIE	La métrorragie au cours de la grossesse désigne toute hémorragie d'origine utérine, lésionnelle ou fonctionnelle se produisant en dehors des règles : - Métrorragie de la première moitié de la grossesse< 22 SA : C'est un saignement vaginal qui survient au cours des 22 premières semaines d'aménorrhée. - Métrorragie de la 2ème moitié de la grossesse (> 22 SA) : Toute spoliation sanguine par voie génitale, même minime est un signe anormal chez la femme enceinte et impose une consultation médicale. - Toute métrorragie même minime est un signe anormal chez la femme enceinte. Elle doit amener la femme à consulter vite et inciter le personnel de santé à explorer sérieusement le cas ;
HTA GRAVIDIQUE	HTA avec Pression Artérielle Systolique ≥ 140 mmhg et/ou Pression Artérielle Diastolique ≥ 90 mm Hg HTA gravidique : si elle est isolée, sans protéinurie apparue à partir de 20 SA → En l'absence d'antécédent

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
PRE ECLAMPSIE	Etat précédant l'apparition des convulsions éclamptiques : - Prééclampsie modérée : ▪ HTAG et protéinurie > 0,3 g/24h ou > 2 croix et de façon variable œdèmes d'apparition ou d'aggravation brutale ; ▪ Chiffres tensionnels : 90< PAD < 110 mm Hg, absence de signes de - Pré éclampsie sévère : HTA grave PAS ≥ 170 mm Hg et/ou PAD ≥ 110 mm Hg ou HTA associée à un ou plusieurs signes : ▪ Signes fonctionnels : Douleurs épigastriques, nausées, vomissements ; céphalées persistantes et intenses, troubles visuels ; ▪ Biologie : ASAT>deux fois la valeur normale, plaquettes < 100000/mm3 ; protéinurie >1g/l ou 3 à 5g/24h.
ECLAMPSIE	Etat convulsif survenant comme complication aiguë paroxystique de la pré-éclampsie (HTA, albuminurie, Œdèmes)
ANEMIE	Anémie sévère : Taux d'hémoglobine < 7 g/dl et /ou pâleur palmaire et conjonctivale sévère, et / ou toute pâleur associée à: - Plus de 30 respirations/min ; - Une faible résistance à l'effort ; - Une tachypnée au repos. - Anémie modérée : Taux d'hémoglobine compris entre 7 et 11 g/dl ou pâleur palmaire ou conjonctivale
DIABETE PREEXISTANT	- C'est une glycémie à jeun ≥1.26g/L au premier trimestre OU - Une glycémie post-prandial ou hasard à n'importe quel moment ≥ 2g/L OU - une hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) a 75g : à jeun ≥1,26g/l ou après ≥1h/2h 2g/l
DIABETE GESTATIONNEL	C'est un trouble de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse (OMS).
CARDIOPATHIE	- Cardiopathies acquises : rétrécissement mitral plus fréquent. - Cardiopathies congénitales : plus fréquentes (communication inter auriculaire et communication inter ventriculaire). - Cardiopathies traitées chirurgicalement.
INFECTION (PRENATAL)	C'est une infection causée par des bactéries, virus ou, dans de rares cas, parasites transmis directement à partir de la mère à l'embryon, le fœtus ou le bébé pendant la grossesse ou l'accouchement.
AUTRES GAR	Toute autre pathologie liée soit à la mère, soit au développement du fœtus, soit à la survenue d'événements spécifiques lors de la grossesse

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
	et qui peuvent courir des risques pour la santé de la mère et/ou celle du fœtus en plus de ceux citées auparavant.
REFERE	Si la femme a été référée à un autre établissement sanitaire pour une éventuelle prise en charge.
PRISE EN CHARGE (PEC)	Si la grossesse à risque a été prise en charge totalement au sein de l'établissement sanitaire.
FEMME COMPLETEMENT SUPPLEMENTEES EN FER	Si la femme a reçu sa dotation complète en comprimés de fer au niveau de l'établissement sanitaire. Toute femme enceinte ayant reçu 120mg de fer élément par semaine pendant 30 semaines à partir de la 12ème semaine d'aménorrhée.

3.2.Consultation en Post Natale

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
POST PARTUM	C'est la période qui commence une heure après la délivrance et qui s'étend jusqu'à six semaines plus tard. Tenant compte des orientations du programme maternité sans risque et vu l'importance des périodes de consultations, il a été retenu de distinguer trois types de consultations (Immédiat, précoce et tardif) et ce selon les délais préconisés à savoir : avant la sortie de la structure d'accouchement pour **le post partum immédiat**, 7 à 9 jours après l'accouchement pour **le postpartum précoce** et entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement pour **le post partum tardif**. Ainsi, les centres de santé sont concernés par **le post partum précoce et tardif** et les structures d'accouchement par **le post partum Immédiat.** - Chaque accouchée ou nouveau-né se présentant pour la première fois à la consultation postnatale (CPoN) est une **"Nouvelle Inscrite / Nouveau Inscrit (NI)"** quel que soit le moment de la consultation en période postnatale - A partir de la deuxième visite au cours de la période postnatale , l'accouchée ou le nouveau-né est dite **"Ancienne / Ancien Inscrit(e) (AI)**".
CONSULTATION DU POST PARTUM IMMEDIAT	C'est la consultation pour le compte de la mère et du nouveau-né et qui doit être faite dans les 48 heures ou à la sortie de l'établissement sanitaire où a eu lieu l'accouchement.
CONSULTATION DU POST PARTUM PRECOCE	C'est la consultation du postpartum qui doit être réalisée entre le 7ème et 9ème jour après l'accouchement.
CONSULTATION DU POST PARTUM TARDIF	C'est la consultation du postpartum qui doit être réalisée entre le 40ème et 50ème jour après l'accouchement.

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
AUTRES CONSULTATIONS DU POST PARTUM	Ce sont les consultations du postpartum qui se font en dehors des 3 consultations du postpartum précitées (immédiat, précoce et tardif) et qui ne respectent pas le suivi préconisé.
MERES	
COMPLICATION EN POST PARTUM	
HEMORRAGIE	Tout saignement anormal survenant pendant la grossesse, l'accouchement ou dans les suites de couches.
INFECTION PUERPERALE	C'est une infection de l'appareil génital survenant dans les suites de couches.
ECLAMPSIE	Etat convulsif survenant comme complication aiguë paroxystique de la pré-éclampsie (HTA, albuminurie, Œdèmes).
PHLEBITE	C'est la constitution d'un caillot dans une veine, associé parfois à une inflammation de la paroi veineuse. Ce caillot entraîne un arrêt du flux sanguin dans la veine obstruée et une hyperpression en amont du caillot.
COMPLICATIONS MAMMAIRES	Il s'agit de : - CREVASSES qui représentent une complication mécanique de l'allaitement au sein. Elles se manifestent par des fissures au niveau du mamelon. Elles sont favorisées par une mauvaise hygiène et un mamelon ombiliqué. - ENGORGEMENT : C'est un trouble de l'excrétion lactée. Il se manifeste par une fébricule à 38°. Les seins deviennent tendus, douloureux et chauds. - INFECTION MAMMAIRE : Elle est favorisée par l'engorgement, les crevasses et le manque d'hygiène. On peut rencontrer deux tableaux cliniques en fonction du stade : ▪ La mastite aigue ; ▪ L'abcès du sein.
ANEMIE	- Anémie sévère : Taux d'hémoglobine < 7 g/dl et /ou pâleur palmaire et conjonctivale sévère, et / ou toute pâleur associée à: ▪ Plus de 30 respirations/min ; ▪ Une faible résistance à l'effort ; ▪ Une tachypnée au repos. - Anémie modérée : Taux d'hémoglobine compris entre 7 et 11 g/dl ou pâleur palmaire ou conjonctivale.
DEPRESSION DU POST PARTUM	Elle survient entre le 15ème jour et le 3ème mois, souvent chez une femme prédisposée (mère célibataire, mauvais soutien du conjoint, manque de satisfaction dans la vie du couple….)
AUTRES COMPLICATION	Ce sont les complications du post partum autres que celles mentionnées ci-dessus.
NOUVEAU-NE	

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
PREMATURITE	Désigne toute naissance survenant entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée révolues et correspondant à un poids supérieur ou égal à 500g.
HYPOTROPHIE	Désigne toute naissance à un poids (et/ou une taille, et/ou un périmètre crânien) significativement inférieur(s) à la normale pour l'âge gestationnel, quel que soit cet âge gestationnel.
NOUVEAU-NES : COMPLICATION EN POST PARTUM	
ICTERE NEONATAL	C'est un ictère ou une jaunisse correspond à la coloration jaune des téguments (peau et muqueuses), on parle d'ictère cutanéo-muqueux dû à l'accumulation de bilirubine qui peut être libre ou conjuguée.
INFECTION MATERNO-FEOTALE POSSIBLE	C'est la contamination du nouveau-né par des germes de la voie Trans placentaire ou par voie ascendante à partir d'une infection cervico-vaginale. Il s'agira alors d'une infection materno-fœtale dont les signes vont apparaître au cours de la première semaine de vie.
CONJONCTIVITE NEONATALE	La conjonctivite néonatale se définit comme un écoulement purulent des yeux qui apparait au cours des quatre premières semaines de vie quelle qu'en soit la cause.
TRAUMATISME	Il s'agit d'un ensemble de complications observés chez les nouveau-nés et résultant de forces mécaniques effectuée pendant le travail. D'une manière générale, il peut s'agir de : ▪ Lésions traumatiques des parties molles ; ▪ Traumatismes crâniens ; ▪ Lésions traumatiques du rachis, de la moelle et des nerfs ▪ Périphériques ; ▪ Lésions traumatiques des os des membres ; ▪ Lésions traumatiques viscérales. Les signes les plus fréquemment observés sont : ▪ Diminution ou absence de la mobilité d'un membre ; ▪ Asymétrie du visage ; ▪ Bosse sérosanguine ou céphalhématome.
AUTRES COMPLICATIONS	Ce sont les complications néonatales autres que celles mentionnées ci-dessus.
REFERE (FEMME OU NOUVEAU-NE)	Concerne la femme (ou nouveau-né) qui a été référée à un autre établissement sanitaire pour une éventuelle prise en charge.
PRISE EN CHARGE (PEC) (FEMME OU NOUVEAU-NE)	Concerne la femme (ou nouveau-né) qui a été prise en charge totalement au sein de l'établissement sanitaire.

3.3.Accouchement et suite de couches

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
MERES	
ACCOUCHEMENT	Ensemble de phénomènes physiologiques (travail puis délivrance) aboutissant à l'expulsion du fœtus et de ses annexes hors des voies génitales maternelles à partir de 28 SA mois (soit 181 jours) de grossesse.
HEMORRAGIE	L'hémorragie est tout saignement anormal survenant pendant la grossesse (à partir de 28 semaine d'aménorrhée), l'accouchement ou dans les suites de couches.
TRAVAIL PROLONGE	Il s'agit d'un travail prolongé est un travail vrai et actif (2-4 CU/10mn) de durée prolongée (phase active du partogramme avec dilatation stationnaire plus de 2h, défaut d'engagement à dilatation complète), N'aboutissant pas à l'accouchement et avec parfois l'apparition : - Chez le fœtus : une souffrance fœtale aiguë, une bosse séro-sanguine ; - Chez la mère: une angoisse et une agitation, un œdème du col utérin.
TRAVAIL BLOQUE	Le travail bloqué est l'arrêt de progression du travail. L'accouchement est impossible sans le recours à une intervention obstétricale (la césarienne, une extraction instrumentale ou manœuvre obstétricale).
PRÉ ÉCLAMPSIE	Etat précédant l'apparition des convulsions éclamptiques : - Pré éclampsie modérée ▪ HTAG et protéinurie > 0,3 g/24h ou > 2 croix et de façon variable Œdèmes d'apparition ou d'aggravation brutale ▪ Chiffres tentionels - Pré éclampsie sévère : HTA grave PAS ≥ 170 mm Hg et/ou PAD ≥ 110 mm Hg ou HTA associée à un ou plusieurs signes
ECLAMPSIE	Etat convulsif survenu comme complication aiguë paroxystique de la pré-éclampsie (HTA, albuminurie, Œdèmes).
INFECTION PUERPERALE	C'est une infection de l'appareil génital survenant dans les suites de couches.
RUPTURE UTERINE	C'est une déchirure de la paroi utérine nécessitant une laparotomie.
COMPLICATION DU A L'AVORTEMENT	Elle peut être spontanée, provoquée par une manœuvre obstétricale, ou survenue sur un utérus cicatriciel (sous péritonéale).
AVORTEMENT COMPLIQUE	C'est un avortement incomplet nécessitant une évacuation utérine par curetage, un avortement hémorragique, ou un avortement avec infection.

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
GROSSESSE EXTRA UTERINE	C'est l'implantation de l'œuf en dehors de la cavité utérine le plus souvent dans la trompe, c'est une urgence chirurgicale
AUTRES COMPLICATIONS OBSTETRICALES DIRECTE	Toute complication obstétricale autre que les sept complications obstétricale directes figurant sur le registre, doit être notée au niveau de la colonne « autres à préciser »
FEMME PEC	Concerne la femme qui a été prise en charge totalement au sein de l'établissement sanitaire.
FEMME REFEREE	Concerne la femme qui a été référée à un niveau supérieur pour une prise en charge adéquate.
FEMME EXAMINEE EN CONSULTATION POST PARTUM IMMEDIAT	Femme examinée en consultation post partum effectué dans les 48 heures ou à la sortie de l'établissement sanitaire où a eu lieu l'accouchement.
FEMME AYANT EFFECTUE UN SEJOUR D'AU MOINS 48 HEURES	Femme ayant effectué un séjour d'au moins 48 heures après l'accouchement dans l'établissement où elle a accouchée.
MISE AU SEIN PRECOCE DANS LA 1ERE HEURE QUI SUIT LA NAISSANCE	Tout nouveau-né mis au sein dans la 1ère heure qui suit la naissance en dehors des nouveaux nés qui nécessitent une réanimation.
NOUVEAU-NE	
NAISSANCE VIVANTE	Une naissance est vivante si elle présente des signes de vie, c'est à dire : elle respire, les battements cardiaques sont perçus, son cordon ombilical est pulsatile et elle présente des mouvements spontanés.
MORT-NE	Un mort-né est un fœtus qui naît après 28 SA. (il pèse plus de 1000g et mesure plus de 32 cm) et qui ne présente pas de signes de vie à la naissance.
MORT-NE FRAIS	Le corps du bébé apparaît normal, à moins d'une malformation associée, et la peau apparaît normale dans sa texture et sa consistance, bien qu'elle puisse être pâle.
MORT-NE MACERE	Le corps du bébé peut être déformé, mou, souvent plus petit que le normal et la peau est décolorée et desquamée.
NOUVEAU NES DECEDES <24H	C'est le décès d'un nouveau-né ayant vécu moins de 24 heures.
PREMATURITE	Toute naissance avant le terme de 37 semaines d'aménorrhée révolues, mais au moins 22 semaines, quel que soit le poids mais au moins 500g.
MALFORMATIONS	Les malformations qui doivent être recherchées systématiquement chez tout nouveau-né en particulier : - Encéphalocèle ; - Myéloméningocèle ; - Pied bot ; - Luxation congénitale de la hanche ; - Fente palatine ou labio-palatine ;

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
	- Epispadias ; - Phimosis ; - Hypospadias ; - Ambiguïté sexuelle ; - Souffle cardiaque ; - Pouls fémoraux absents ; - Eléments en faveur d'une trisomie 21.
ICTERE NEONATAL	Un ictère ou jaunisse correspond à la coloration jaune des téguments (peau et muqueuses : on parle d'ictère cutanéo-muqueux) due à l'accumulation de bilirubine, qui peut être libre ou conjuguée. - L'ictère peut être plus ou moins intense. Il doit être recherché à la lumière naturelle. - L'ictère peut être GRAVE nécessitant ainsi un transfert d'urgence à l'hôpital dans les cas suivants : - Ictère précoce (dans les 2 premiers jours de vie), OU - Ictère d'apparition tardive ou persistant au-delà du 10ème jour de vie OU - Présence d'antécédents d'ictère néonatal pathologique dans la fratrie, OU - Selles décolorées, OU - Ictère palmo-plantaire, OU - Ictère associé à une pâleur de la paroi abdominal, OU - Ictère associé à l'un des signes d'infection bactérienne grave, - Ictère isolé et prolongé au-delà du 10ème jour de vie chez le nouveau-né à terme et 15ème jour chez le prématuré ou de faible poids, OU - Ictère d'apparition tardive (au-delà de 10ème jour de vie), OU Ictère isolé chez un nouveau-né de moins de 10 jours. Dans les autres cas suivants, il s'agit d'un ICTERE PATHOLOGIQUE nécessitant un bilan et avis spécialisé : - Ictère isolé et prolongé au-delà du 10ème jour de vie chez le nourrisson né à terme et au-delà du 15ème jour chez le prématuré ou de faible poids, OU - Ictère d'apparition tardive (au-delà du 10ème jour de vie). Pour le cas suivant il s'agit d'un ICTERE BENIN PROBABLE à surveiller : Ictère isolé chez un nourrisson de moins de 10 jours.
INFECTION MATERNO-FEOTALE	C'est la contamination du nouveau-né par des germes par voie transplacentaire ou par voie ascendante à partir d'une infection cervico-vaginale souvent après une rupture prématurée des membranes ou lors du passage du nouveau-né dans la filière génitale. Il s'agira alors d'une infection materno-fœtale dont les signes vont apparaître au cours de la première semaine de vie.

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
	On retient l'infection materno-fœtale chez un nouveau-né de moins de 7 jours qui présente l'un des signes suivants : - Fièvre chez la mère (>38 °C) au moment de l'accouchement ou durant la dernière semaine de la grossesse OU - Rupture de la poche des eaux de plus de 18 heures OU - Infection maternelle traitée par des antibiotiques durant la dernière semaine de la grossesse OU Signe d'affection grave chez le nouveau-né : - Convulsions OU - Respiration rapide (60 respirations par minute ou plus) OU - Respiration lente (inférieure à 30 respirations par minute) OU - Tirage sous-costal marqué OU - Battement des ailes du nez OU - Geignement expiratoire OU - Léthargique ou inconscient OU - Mouvements inférieurs à la normale OU - Cyanose péribuccale.
TRAUMATISME	Il s'agit d'un ensemble de complications observés chez les nouveau-nés et résultant de forces mécaniques pendant le travail. D'une manière générale, il peut s'agir des : - Lésions traumatiques des parties molles ; - Traumatismes crâniens ; - Lésions traumatiques du rachis, de la moelle et des nerfs périphériques ; - Lésions traumatiques des os des membres ; - Lésions traumatiques viscérales. Les signes les plus fréquemment observés sont : - Diminution ou absence de la mobilité d'un membre ou Asymétrie du visage ; ou - Bosse séro-sanguine ou - Céphalhématome.
INSUFFISANCE PONDERALE	Il s'agit d'un poids égal ou inférieur à moins 2DS par rapport à l'âge. On utilise la courbe de croissance de l'OMS adaptée au sexe de l'enfant.
AUTRES COMPLICATIONS	Toute complication néo-natale autre que les complications figurant sur le registre, doit être notée au niveau de la colonne « autres à préciser »
MALFORMATION DU NOUVEAU-NE AVEC SPINA BIFIDA	C'est un défaut de fermeture du tube neural durant la vie embryonnaire, qui reste ouvert à son extrémité caudale. Il en résulte l'absence d'un ou de plusieurs arcs vertébraux de la moelle épinière, provoquant une protursion de la moelle.
MALFORMATION DU NOUVEAU-NE	C'est l'absence ou le développement incomplet du cerveau, donnant un

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
AVEC ANENCEPHALIE	aspect de petit crâne. Elle est incompatible avec la vie.
FENTES PALATINES	C'est une absence de substance de la voûte buccale aboutissant à une communication entre le nez et la bouche.
FENTES LABIALES	C'est une absence de fusion du tissu embryonnaire de la face aboutissant à une perte de substance de la lèvre supérieure. Elle peut être unie ou bilatérale. Le diagnostic est facile par simple inspection. Il faut toujours rechercher une fente palatine à la palpation avec le doigt qui est cachée par la muqueuse qui paraît normal.
FENTES LABIO-PALATINES	Les fentes labio-palatines associent : - Une fente labiale qui est une absence de fusion du tissu embryonnaire de la face aboutissant à une perte de substance de la lèvre supérieure. - Une fente palatine qui est une absence de substance de la voûte buccale aboutissant à une communication entre le nez et la bouche.
AUTRES (MALFORMATIONS)	Les malformations qui ne figurent pas dans la bouclette : - Pied bot ; - Luxation congénitale de la hanche ; - Epispadias ; - Phimosis ; - Hypospadias ; - Ambiguïté sexuelle ; - Souffle cardiaque ; - Pouls fémoraux absents ; - Eléments en faveur d'une trisomie 21. - Fentes labiales - Omphalocèle - Laparoschisis - Extrophie vésicale - Artère ombilicale unique - Atrésie des choanes (cathétérisme nasal bilatéral) - Atrésie de l'œsophage (test à la seringue) - Imperforation anale (thermomètre ou sondage anal)
DEPISTAGE NEONATAL DE L'HYPOTHYROÏDIE CONGENITALE	Il est basé sur le dosage de la ThyréoStimuline Hormone (TSH) sur papier buvard et un test de confirmation sur le sang veineux basé sur le dosage de TSH, T3 et T4.

Les Fonctions Essentielles des Soins Obstétricaux et Néonatals d'Urgence	
F1	Administration d'antibiotiques par voie parentérale.
F2	Administration d'utéro-toniques(ex. misoprostol, ocytociques par voie parentérale).
F3	Administration d'anticonvulsivants par voie parentérale(ex. sulfate de magnésium).
F4	Délivrance artificielle du placenta (extraction manuelle du placenta).
F5	Evacuation des produits résiduels, révision utérine.
F6	Accouchement par voie basse assisté par venteuse.
F7	Réanimation du nouveau-né avec ballon et masque.
F8	Pratique de la césarienne et de laparotomie
F9	Pratique de la transfusion sanguine
Une structure de **SONU de base** prodigue les fonctions essentielles de F1 à F7.	
Une structure de **SONU complets** prodigue les fonctions essentielles de F1 à F9.	

4. VACCINATION

4.1.Performances

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
ENFANT DE MOINS DE 5ANS	
ENFANTS NES PROTEGES	Ces enfants dont les mères ont été vaccinées contre le tétanos (+ de 3 doses)
BCG	**Vaccin contre la tuberculose :** chaque nourrisson doit recevoir une seule prise de BCG le plutôt possible après la naissance
PENTA (DTC-HIB-HB)	**Vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections invasives dues à l'Haemophilus influenza type b et le Vaccin contre l'hépatite B :** ce vaccin pentavalent doit être administré en trois doses : - Penta 1 à l'âge de 2 mois ; - Penta 2 à l'âge de 3 mois ; - Penta3 à l'âge de 4 mois
HB1N	**Vaccin contre l'hépatite B :** chaque nouveau-né doit recevoir la 1^{ére}dose dans les 24 heures après sa naissance ; **Si non**, administrer la 1ère dose du HB1n quand le nouveau-né se présente pour recevoir le BCG.
VPO	**Vaccin contre la poliomyélite :** chaque enfant doit recevoir 6 doses de VPO : - la dose VPO zéro avec le BCG à la naissance ; - la dose 1 à l'âge de 2 mois avec le Penta 1 ; - la dose 2 à l'âge de 3 mois avec le Penta 2 ; - la dose 3 à l'âge de 4 mois avec le Penta 3 ; - la dose 4 à l'âge de 18 mois (1er rappel) ; - la dose 5 à l'âge de 5 ans (2ème rappel).
VPI :	Une dose à l'âge de 4 mois
DTC :	**Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche :** pour renforcer l'immunité contre ces trois maladies, chaque enfant doit recevoir : - une dose à l'âge de 18 mois (1er rappel) associée au VPO ; - une dose à l'âge de 5 ans (2ème rappel) associée au VPO.
ROTAVIRUS	**Vaccin anti Rotavirus :** Ce vaccin peut être disponible soit en deux doses ou en trois doses à administrer respectivement : - <u>Si utilisation de Rotavirus série 2 doses :</u> ▪ ROTA1 à l'âge de 2 mois ;

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
	▪ ROTA2 à l'âge de 3 mois. - <u>Si utilisation de Rotavirus série 3 doses :</u> ▪ ROTA1 à l'âge de 2 mois ; ▪ ROTA2 à l'âge de 3 mois ; ▪ ROTA3 à l'âge de 4 mois.
PNEUMOCOQUE	**Vaccin contre les infections invasives dues au pneumocoque :** ce vaccin devra être administré en trois doses respectivement à l'âge de : - VCP1 à l'âge de 2 mois ; - VCP2 à l'âge de 4 mois ; - VCP3 à l'âge de 12 mois.
HPV	**La vaccination contre les papillomavirus, cible, pour lancement de cette vaccination : les filles de 11 ans** - HPV1, - HPV2 : au moins 6 mois après la deuxième dose sans dépasser 15 mois.
FEMME	
Td	**Le vaccin Td** est un vaccin qui protège contre le tétanos et la diphtérie. Il est recommandé aux personnes de 7 ans ou plus notamment les femmes en âge de procréer. - **Td 1** : Dès que possible chez la femme en âge de procréer ou le plus tôt possible en cours de la grossesse - **Td 2** : Au moins 4 semaines après le Td 1 - **Td 3** : Au moins 6 semaines après le Td 2 - **Td 4** : Au moins 1 an après le Td 3 - **Td 5**: Au moins 1 an après le Td 4 ou au cours d'une grossesse ultérieur

4.2.Ressources

PRODUITS DISTRIBUES	UNITES DE GESTION
BCG	
DTC (RAPPELS)	
VPO	
VPI	
HEP B	
DTC-HIB-HEP.B (PENTA)	
ROTAVIRUS (2 DOSES)	
ROTAVIRUS (3 DOSES)	
PNEUMOCOQUE	
RR	
TD	
HPV	

4.3.Calendrier National de Vaccination des Enfants de moins de 5 ans

Programme National d'Immunisation
calendrier national de vaccination

Vaccins recommandés pour les enfants de moins de 5 ans

Age / Antigènes	Naissance	Durant le premier mois	2 Mois	3 Mois	4 Mois	9 Mois	12 Mois	18 Mois	5 ans
Vaccin contre l'hépatite B (HB)	HB1n (24h) administrée à la maison d'accouchement ou maternité hospitalière ou clinique privée.								
	Dose non administrée durant les 24 heures	Dose 1							
Vaccin anti BCG (tuberculose)		Dose 2							
larO oiloP itna niccaV		Dose 0	Dose 1	Dose 2	Dose 3			Dose 4	Dose 5
Vaccin anti Pneumoccique			Dose 1		Dose 2		Dose 1		
Vaccin anti Rotavirus (Série de 3 doses)			Dose 1	Dose 2	Dose 3				
Vaccin anti DTC-Hib-HB (Vaccin Pentavalent)			Dose 1	Dose 2	Dose 3				
VPI					Dose 1				
Vaccin combiné RR						Dose 1		Dose 2	
Vaccin anti DTC								Rappel 1	Rappel 2

5. NUTRITION

5.1.Performances

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
MESURES ANTHROPOMETRIQUES	
INSUFFISANCE PONDERALE	(P/A < - 2DS)
RETARD DE CROISSANCE	(T/A < -2DS)
MALNUTRITION	(IMC/A < -2DS)
SURPOIDS	(+2DS < IMC/A ≤+3DS)
OBESITE	(IMC/A > + 3DS)
ALLAITEMENT MATERNEL	
ALLAITEMENT EXCLUSIF AU SEIN	Appeler aussi **allaitement maternel exclusif (AME)**, c'est quand le nouveau-né ou nourrisson reçoit uniquement du lait maternel, aucun autre aliment n'est donné même pas l'eau durant les 6 premiers mois de vie

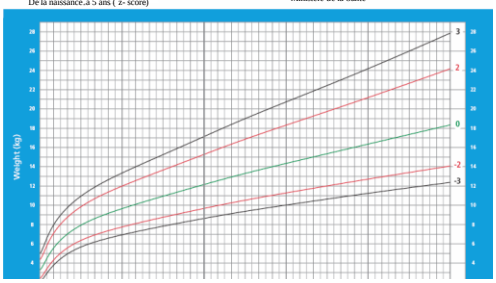
5.2.Courbes de croissance

COURBES DE CROISSANCE	
POURQUOI CES COURBE ?	L'évaluation de l'état nutritionnel des enfants à travers 4 indicateurs : Poids pour âge; Taille pour âge ; Indice de Masse corporel par rapport à l'âge; Périmètre crânien pour âge.
QUI DOIT LA REMPLIR ?	Médecins et Infirmiers (ère s) de SMI.
QUAND ?	Au moment de chaque prestation.
COMMENT ?	- 4 types de courbes proposées et disponibles dans le carnet de santé de l'enfant (garçon ; fille) ; - Tableaux conçus pour déduire l'indice de masse corporelle (disponibles dans le carnet de santé de l'enfant). - Voir les instructions de remplissage.

Poids / Age (Garçons)

Ministère de la Santé

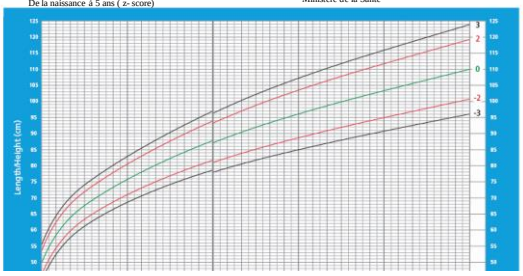
De la naissance à 5 ans (z- score)



Taille / Age (Garçons)

Ministère de la Santé

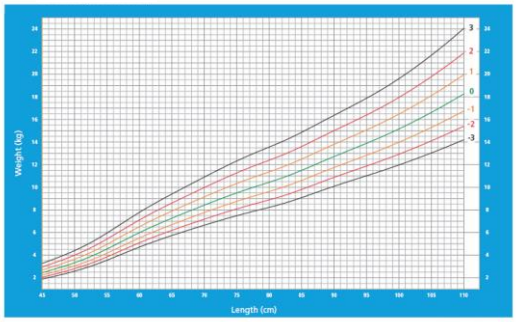
De la naissance à 5 ans (z- score)



Poids / Taille (Garçons)

Ministère de la Santé

De la naissance à 2 ans (z- score)

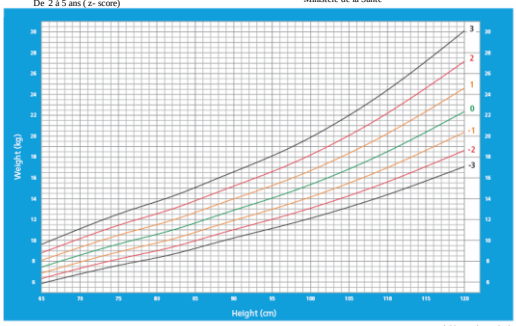


WHO Child Growth Standards

Poids / Taille (Garçons)

Ministère de la Santé

De 2 à 5 ans (z- score)

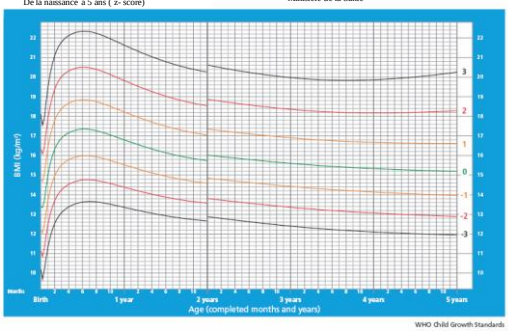


WHO Child Growth Standards

BMI en fonction de l'âge (Garçons)

Ministère de la Santé

De la naissance à 5 ans (z- score)

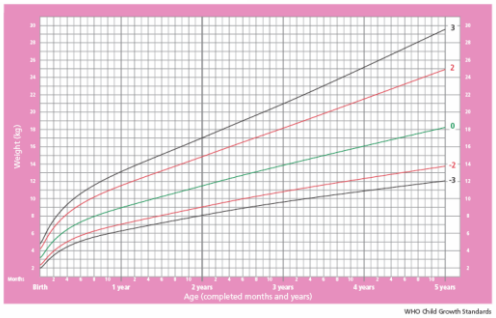


WHO Child Growth Standards

Poids / Age (Filles)

Ministère de la Santé

De la naissance à 5 ans (z- score)



WHO Child Growth Standards

Taille / Age (Filles)

Ministère de la Santé

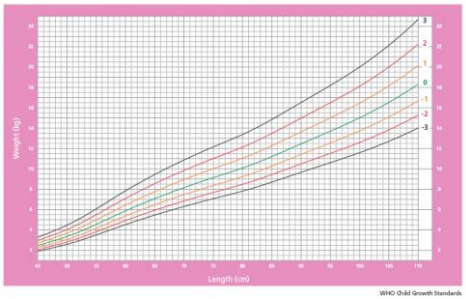
De la naissance à 5 ans (z- score)



Poids / Taille (Filles)

Ministère de la Santé

De la naissance à 2 ans (z- score)

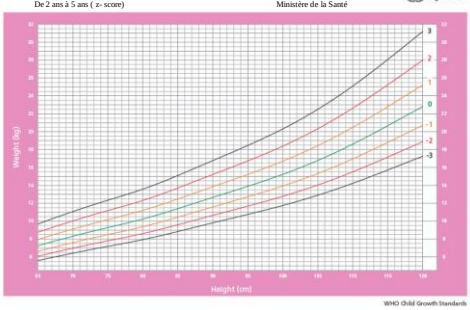


WHO Child Growth Standards

Poids / Taille (Filles)

Ministère de la Santé

De 2 ans à 5 ans (z- score)

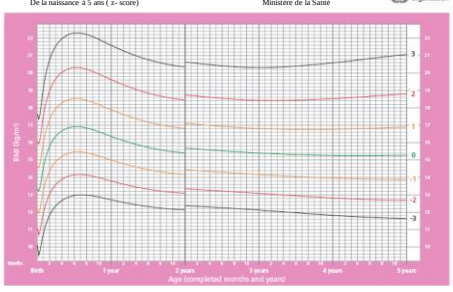


WHO Child Growth Standards

BMI en fonction de l'âge (Filles)

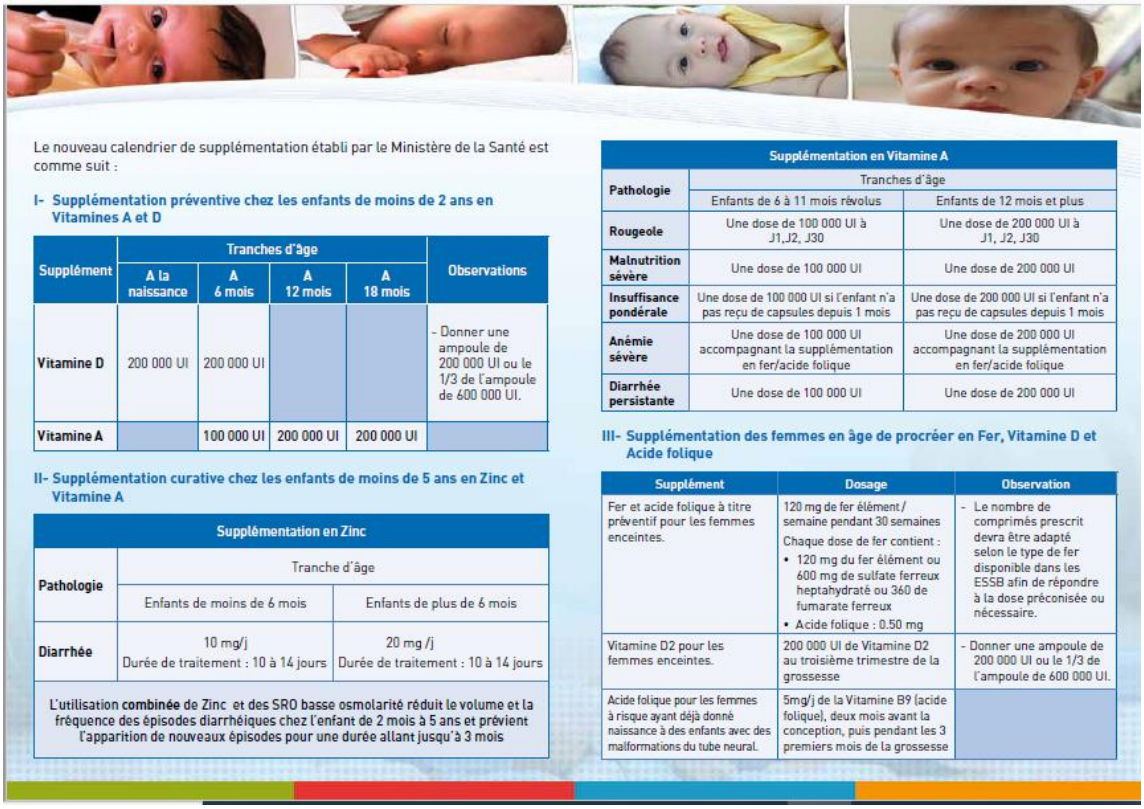
Ministère de la Santé

De la naissance à 5 ans (z- score)



INTERPRETATION DES COURBES DE CROISSANCE			
	Poids/âge	**Taille/âge**	**IMC/âge**
Plus de 3 DS	Pour classer l'état nutritionnel, se référer à l'IMC/âge	Grande taille	**OBESITE**
Plus de 2 DS	Pour classer l'état nutritionnel, se référer à l'IMC/âge		**SURPOIDS**
Plus de 1 DS	Normal	Normal	**RISQUE DE SURPOIDS**
0 (médiane)	Normal	Normal	Normal
Moins de 1 DS	Normal	Normal	**RISQUE DE MALNUTRITION**
Moins de 2 DS	**INSUFFISANCE PONDERALE**	**RETARD DE CROISSANCE MODERE (Petite taille)**	**MALNUTRITION MODEREE (Maigre)**
Moins de 3 DS	**INSUFFISANCE PONDERALE SEVERE**	**RETARD DE CROISSANCE SEVERE (Très petite taille)**	**MALNUTRITION SEVERE (Très maigre)**

5.3.Calendrier de supplémentation des enfants de moins de 5 ans



Le nouveau calendrier de supplémentation établi par le Ministère de la Santé est comme suit :

I- Supplémentation préventive chez les enfants de moins de 2 ans en Vitamines A et D

Supplément	Tranches d'âge				Observations
	A la naissance	A 6 mois	A 12 mois	A 18 mois	
Vitamine D	200 000 UI	200 000 UI			- Donner une ampoule de 200 000 UI ou le 1/3 de l'ampoule de 600 000 UI.
Vitamine A		100 000 UI	200 000 UI	200 000 UI	

II- Supplémentation curative chez les enfants de moins de 5 ans en Zinc et Vitamine A

Supplémentation en Zinc		
Pathologie	Tranche d'âge	
	Enfants de moins de 6 mois	Enfants de plus de 6 mois
Diarrhée	10 mg/j Durée de traitement : 10 à 14 jours	20 mg /j Durée de traitement : 10 à 14 jours
L'utilisation combinée de Zinc et des SRO basse osmolarité réduit le volume et la fréquence des épisodes diarrhéiques chez l'enfant de 2 mois à 5 ans et prévient l'apparition de nouveaux épisodes pour une durée allant jusqu'à 3 mois		

Supplémentation en Vitamine A		
Pathologie	Tranches d'âge	
	Enfants de 6 à 11 mois révolus	Enfants de 12 mois et plus
Rougeole	Une dose de 100 000 UI à J1,J2, J30	Une dose de 200 000 UI à J1, J2, J30
Malnutrition sévère	Une dose de 100 000 UI	Une dose de 200 000 UI
Insuffisance pondérale	Une dose de 100 000 UI si l'enfant n'a pas reçu de capsules depuis 1 mois	Une dose de 200 000 UI si l'enfant n'a pas reçu de capsules depuis 1 mois
Anémie sévère	Une dose de 100 000 UI accompagnant la supplémentation en fer/acide folique	Une dose de 200 000 UI accompagnant la supplémentation en fer/acide folique
Diarrhée persistante	Une dose de 100 000 UI	Une dose de 200 000 UI

III- Supplémentation des femmes en âge de procréer en Fer, Vitamine D et Acide folique

Supplément	Dosage	Observation
Fer et acide folique à titre préventif pour les femmes enceintes.	120 mg de fer élément/ semaine pendant 30 semaines Chaque dose de fer contient : • 120 mg du fer élément ou 600 mg de sulfate ferreux heptahydraté ou 360 de fumarate ferreux • Acide folique : 0.50 mg	- Le nombre de comprimés prescrit devra être adapté selon le type de fer disponible dans les ESSB afin de répondre à la dose préconisée ou nécessaire.
Vitamine D2 pour les femmes enceintes.	200 000 UI de Vitamine D2 au troisième trimestre de la grossesse	- Donner une ampoule de 200 000 UI ou le 1/3 de l'ampoule de 600 000 UI.
Acide folique pour les femmes à risque ayant déjà donné naissance à des enfants avec des malformations du tube neural.	5mg/j de la Vitamine B9 (acide folique), deux mois avant la conception, puis pendant les 3 premiers mois de la grossesse	

5.4.Ressources

PRODUITS DISTRIBUES	UNITES DE GESTION
Vitamine D	Ampoule
Vitamine A (100000 UI)	Capsule
Vitamine A (200000 UI)	Capsule
Fer	Comprimés
Zinc	Comprimés
SRO	Sachets
acide folique	Comprimés

6. CONSULTATION MEDICALE DE L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS

CONCEPTS		DEFINITIONS
TYPE DE VISITE	1ERE VISITE	Premier contact avec la structure de santé pour le problème de santé actuel
	VISITE DE SUIVI	Retour de l'enfant alors qu'il a déjà été vu et traité pour le même problème quelques jours auparavant (demander à la mère, puis vérifier sur le registre et le carnet de santé de l'enfant)
INFECTION	INFECTION BACTERIENNE GRAVE	A suspecter devant : - convulsions ou - Respiration rapide (60 respirations par minute ou plus) ou - Tirage sous-costal marqué ou - Battement des ailes du nez ou - Geignement expiratoire ou - Léthargique ou inconscient ou - Mouvements inférieurs à la normale ou - Fontanelle bombée ou - Ecoulement de pus de l'oreille ou - Rougeur ombilicale gagnant la peau ou - Fièvre (38°C* ou plus, ou corps chaud au toucher), ou hypothermie (en-des-sous de 36°C* ou froid au toucher) ou - Pustules cutanées nombreuses (plus de 10) ou sévères (bulles).
	INFECTION LOCALE	A suspecter devant : - Pus dans les yeux ou - Ombilic rouge ou suintant de pus ou - Pustules cutanées ou - Plaques blanches dans la bouche (muguet).
ICTERE	ICTERE PATHOLOGIQUE GRAVE	- Ictère précoce (dans les 36 heures de vie), ou - Ictère palmo-plantaire, ou - Ictère associé à une pâleur de la paroi abdominale, ou - Ictère associé à l'un des signes d'infection bactérienne grave, ou - Présence d'antécédents d'ictère néonatal pathologique dans la fratrie ou - Selle décolorées
	ICTERE PATHOLOGIQUE	- Ictère isolé et prolongé au-delà du 10ème jour de vie chez le nourrisson né à terme et au-delà du 15ème jour chez le prématuré ou de faible poids, ou - Ictère d'apparition tardive (au-delà du 10ème jour de vie).

	ICTERE BENIN PROBABLE	Ictère isolé chez un nourrisson de moins de 10 jours.
DIARRHEE	**DHA SEVERE**	Deux des signes suivants : - Léthargique ou inconscient. - Yeux enfoncés. - Incapable de boire ou boit difficilement. Pli cutané persistant.
	DHA MODEREE	Deux des signes suivants : - Agité et irritable. - Yeux enfoncés. - Boit avidement, assoiffé. Pli cutané pâteux.
	DIARRHEE AIGUE SANS DHA	L'émission de plus de 3 selles consistantes très molles à liquides par jour d'évolution brutale depuis moins de deux semaines (sauf chez le nourrisson allaité au sein ou la diarrhée est définie comme un changement d'aspect des selles ou une augmentation de sa fréquence), avec : Pas assez de signes pour classer comme déshydratation modérée ou sévère.
	DIARRHEE PERSISTANTE SEVERE	Diarrhée de plus de 14 jours **ET** : - Enfant de moins de 6 mois ou Déshydratation chez un enfant de 6 mois ou plus
	DIARRHEE PERSISTANTE	Diarrhée de plus de 14 jours **ET :** Enfant de 6 mois ou plus sans déshydratation.
	Dysenterie	Diarrhée avec sang dans les selles avec ou sans glaire.
PROBLEMES DE STIMULATION DU DEVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF		En cas de pratiques parentales sévères ou négligentes, par défaut ou par excès. Manque d'interaction bienveillante et attentive des parents avec l'enfant, notamment à travers le jeu et la communication (visuelle, corporelle, vocale et affective)
PROBLEME GRAVE (MALADIE TRES GRAVE)		Tout enfant **avec au moins** l'un des signes suivants : - Incapable de boire ou de prendre le sein ou - Vomit tout ce qu'il consomme ou - A eu des convulsions durant la maladie actuelle ou - Léthargique ou inconscient ou Convulse actuellement
PNEUMOPATHIE	**PNEUMOPATHIE GRAVE AVEC SIFFLEMENT**	- Stridor chez un enfant calme avec sifflement, ou Tirage sous costal avec sifflement
	PNEUMOPATHIE GRAVE SANS SIFFLEMENT	- Stridor chez un enfant calme sans sifflement, ou - Tirage sous costal sans sifflement
	PNEUMOPATHIE AVEC SIFFLEMENT	Respiration rapide associée à un sifflement malgré le traitement d'épreuve (administration de 4 bouffées de bronchodilatateurs à l'aide d'une chambre d'inhalation)

	PNEUMOPATHIE SANS SIFFLEMENT	Respiration rapide
	BRONCHIOLITE AIGUE VIRALE 1ER ÉPISODE	Le premier épisode aigu de gêne respiratoire (séquence rhinite suivie de signes respiratoires : toux, sibilants et/ou crépitants, accompagnés ou non d'une polypnée et/ou de signes de lutte respiratoire), intervenant à toute période de l'année
	BRONCHIOLITE AIGUE VIRALE 2ÈME ÉPISODE	Le deuxième épisode de dyspnée sifflante chez le nourrisson de moins de 2 ans
	SIFFLEMENT 1ER ET 2EME EPISODE	Son musical et doux observé à l'expiration.
	ASTHME PROBABLE SIFFLEMENT "3EME EPISODE"	À partir du 3ème épisode de bronchiolite avant l'âge de 2 ans, on considère qu'il s'agit d'asthme du nourrisson et la prise en charge est différente.
	TOUX OU RHUME (PAS DE PNEUMOPATHIE NI DE SIFFLEMENT)	- Pas de signe de pneumopathie grave, et - Pas de signe de pneumopathie, et - Pas de sifflement.
ANGINE		Fièvre ou mal de gorge **ET** deux des 3 signes suivants : - Gorge rouge - Taches blanchâtres dans la gorge. Adénopathies sous maxillaires douloureuses.
PROBLEME D'OREILLE	**MASTOÏDITE**	Infection bactérienne des cellules aérienne mastoïdiennes, généralement après une otite moyenne se traduisant généralement par : - Rougeur, - Douleur et tuméfaction rétro-auriculaire, Fluctuation mastoïdienne et refoulement du pavillon auriculaire.
	INFECTION AIGUË DE L'OREILLE	Infection bactérienne ou virale de l'oreille moyenne se traduisant par : - Un écoulement de pus visible depuis moins de 14 jours Ou Douleur à l'oreille.
MENINGITE DIAGNOSTIQUE CLINIQUEMENT		Infection bactérienne aigue rapidement évolutive des méninges et de l'espace sous-arachnoïdien. les signes comprennent généralement Fièvre **ET** : - Raideur de la nuque ou - Fontanelle bombée - Céphalées
ROUGEOLE PROBABLE CLINIQUEMENT		Rougeole actuelle ou dans les trois derniers mois suspectée devant : - éruptions cutanées maculopapuleuses ou sur la muqueuse buccale (taches de koplik : taches rouge vif avec centre des centres blanc bleuâtre) **ET l'un des signes suivants :**

	Fièvre, coryza, conjonctivite/yeux rouges, photophobie, toux.
ANEMIE CHEZ L'ENFANT	Baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang par rapport à la valeur normale : Un seuil inférieur à 14 g/dl chez un nouveau-né
TROUBLES DU COMPORTEMENT, DU DEVELOPPEMENT ET EMOTIONNELS	Perturbation dans l'acquisition ou l'expression d'habilités développementales, ces troubles incluent : - La paralysie cérébrale. - Le retard global de développement (lenteur d'acquisition par rapport aux normes dans un ou plusieurs domaines du développement). - Le trouble primaire du langage. - Le trouble du spectre autistique. - Le trouble du déficit de l'attention avec /ou sans hyperactivité (TDA/H). - Les troubles d'apprentissage. - Les troubles d'acquisition de la coordination (TAC). Anomalies génétiques et chromosomique.
PRIS EN CHARGE	Pour chaque enfant malade, sa prise en charge doit se conformer aux **6 étapes suivantes :** 1. Accueillir l'enfant et sa mère. 2. Evaluer l'enfant et ses constantes. 3. Relever les problèmes et les classer par gravité pour définir les priorités. 4. Identifier la ou les conduites à tenir pour la prise en charge à l'aide d'un arbre décisionnel. 5. Traiter l'enfant en conséquence. 6. informer et rassurer la mère sur les oins prodigués à son enfant puis la conseiller pour leur poursuite à domicile.
REFERENCE	- d'urgence à l'hôpital - A froid (avis spécialisé ou bilan complémentaire).
EXAMENS SYSTEMATIQUES	**13 examens** depuis la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, rapportés sur le carnet de santé de l'enfant et qui renseignent les données essentielles sur la croissance, les étapes du développement psychomoteur et intellectuel, l'examen physique et sensoriel, les vaccinations dont l'objectif est : - Le dépistage et l'identification précoce des malformations, des pathologies métaboliques et génétiques, des handicaps ou déficits, - l'évaluation staturo-pondérale, - l'évaluation du psychomoteur, de la vision et l'audition, - l'évaluation du respect des besoins psycho affectifs, nutritionnels, matériel de l'enfant, - la prévention et l'éducation de l'enfant au travers des informations échangées avec les parents. **Calendrier des examens systématiques :** - A la naissance. - Durant le premier mois.

	- Fin du deuxième mois. - Fin du quatrième mois. - Fin du sixième mois. - Fin du neuvième mois. - Fin du douzième mois. - Fin du dix huitième mois. - Fin du vingt quatrième mois. - Fin du trente sixième mois - Visite médicale systématique du préscolaire (entre 3 et 5 ans). - Visite médicale à la première année du primaire. - Visite médicale à la première année du collège.
Troubles ophtalmologiques probable	Présence de : - Anomalie des paupières, ou - Opacité de la cornée, ou - Lueur blanche pupillaire, ou - Nystagmus, ou - Amblyopie (comportement anormal ou indifférent à l'entourage), ou - Absence de Reflexes protomoteurs, ou - Strabisme, ou - Manque d'intérêt aux stimuli visuels, ou - Errance du regard, ou - Baisse de l'acuité visuelle (difficulté à réaliser des taches et lenteur d'exécution chez le petit enfant après 2 ans et demi).
DEFICITS AUDITIFS PROBABLE	• **Dans les premiers mois :** - Observer la réaction aux bruits, aux vibrations ; - Observer si sommeil trop calme. • **De 3 à 12 mois :** - Absence de réaction à l'appel de son nom. • **De 12 à 24 mois :** - Observer si l'enfant est inattentif à ce qui n'est pas dans son champ visuel ; - Emissions vocales incorrectes. • **De 24 à 36 mois :** - Rechercher un retard de parole et de langage ; - Rechercher des troubles du comportement relationnel : retrait agitation. • **Après 3 ans :** - Rechercher des difficultés d'apprentissage ; Régression de l'expression vocale ; Détérioration de la parole articulée.

7. IST SIDA

7.1.Déclaration syndromique des cas d'IST

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
ECOULEMENT URETRAL	Ecoulement inhabituel provenant du méat urétral
ECOULEMENT URETRAL RECURENT	Ecoulement urétral qui persiste malgré un traitement syndromique adéquat
ULCERATION GENITALE	Lésion ulcérative, vésiculeuse ou crouteuse, unique ou multiple, parfois en bouquet, douloureuse ou non, propre ou purrulente, siégeant sur la région génitale, accompagnée ou non d'adénopathie inguinale.
PERTES VAGINALES	Toutes pertes inhabituelles, non physiologiques, provenant du vagin ou du col utérin, pouvant être malodorantes, purulentes ou sanguinolentes, accompagnées ou non de prurit ou de signes inflammatoires de la paroi vaginale ou de lésions cervicales. En fonction des résultats de l'utilisation de l'algorithme deux types d'atteintes pourront être notifiées : vaginite ou cervicite.
VAGINITE ISOLEE	Pertes vaginales non accompagnées de facteurs de risque ni de signes physiques de cervicite, tel que définis dans l'algorithme en vigueur.
CERVICITE	Pertes vaginales accompagnées de facteurs de risque et/ou de signes physiques de cervicite, tel que définis dans l'algorithme en vigueur.
MALADIE INFLAMMATOIRE PELVIENNE (MIP)	Douleurs du bas ventre rapportées par la patiente, accompagnées de douleurs à la mobilisation de l'utérus et/ou de tout autre signe d'examen lié à la MIP, tel que définis dans l'algorithme en vigueur.
CONDYLOME ACUMINES	Toute papule plate ou bombée, mamelonnée, siégeant sur la région génitale.
CONJONCTIVITE NEONATALE	Ecoulement purulent des yeux qui apparait au cours des quatre premières semaines de vie, quelle qu'en soit la cause.

NB : l'infection par le VIH est non incluse dans la déclaration syndromique des IST. Elle fait l'objet d'une Déclaration à part)

7.2.Surveillance de la syphilis chez la femme enceinte et nouveau-né

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
TESTEE POUR LA SYPHILIS	Toute femme enceinte bénéficiant de services de soins prénataux qui a été soumise à un test de dépistage de la syphilis abstraction faite de la nature du test utilisé.
POSITIVE AU TEST RAPIDE DE LA SYPHILIS	Toute femme enceinte bénéficiant de services de consultations prénatales dont le test de dépistage de la syphilis s'est révélé positif (Test Rapide)
POSITIVE AU VDRL	Toute femme enceinte bénéficiant de services de consultations prénatales dont le test de dépistage de la syphilis s'est révélé positif (VDRL)
POSITIVE AU TPHA	Toute femme enceinte bénéficiant de services de consultations prénatales dont le test de dépistage de la syphilis s'est révélé positif (TPHA)
TRAITEE POUR LA SYPHILIS	Toute femme recevant des soins prénataux dont le test de dépistage de la syphilis s'est révélé positif qui a reçu au moins une dose de pénicilline benzathine 2.4 MU par voie intramusculaire
SYPHILIS CONGENITALE	Les cas de syphilis congénitale sont définis comme suit : 1) naissance vivante ou perte fœtale à plus de 20 semaines de gestation ou plus de 500 grammes (morti-naissance comprise) chez une mère séropositive pour la syphilis sans traitement approprié contre la maladie ; 2) naissance vivante, morti-naissance ou enfant âgé de moins de deux ans chez une mère séropositive pour la syphilis ou dont l'état sérologique est inconnu qui présente des signes d'infection par la syphilis (données de laboratoire, de radiographie ou cliniques) (quel que soit le moment ou l'efficacité du traitement de la mère).

7.3.Dépistage du VIH

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
TESTE POUR VIH	Toute personne ayant fait un test rapide de VIH et reçu son résultat dans la structure sanitaire.
POSITIF AU TEST DU VIH	Toute personne ayant fait un test rapide de VIH et dont le résultat s'est révélé positif
CATEGORIES DE LA POPULATION	Toute personne testée doit appartenir à une population cible et si elle présente 2 états de santé ou a 2 profils ou plus, exemple FE et TS, il faut faire une priorisation selon l'ordre mentionné en bas : 1. Femme enceinte

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
	2. TB : Tuberculose, pulmonaire ou extra pulmonaire 3. IST : Infection sexuellement transmissible 4. TS : Travailleuses de sexe 5. HSH : Homme qui a des rapports sexuels avec des hommes 6. PID : Personne qui s'injecte les drogues 7. Migrant 8. Autres populations

7.4. Elimination de la transmission mère-enfant du VIH/syphilis congénitale – centre réfèrent-

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
NOUVEAU-NE EXPOSE AU VIH REFERES	Tout enfant né de mère séropositive au VIH
NOUVEAU-NES SOUS TRAITEMENT ARV PROPHYLACTIQUE	Tout nouveau-né de mère séropositive, bénéficiant d'une mono ou d'une trithérapie par les ARV, dans le but de prévenir le risque de transmission mère-enfant du VIH.
NOMBRE DE NOURRISSONS QUI ONT FAIT UNE PCR DANS LES DEUX MOIS QUI SUIVENT LA NAISSANCE	Nombre de nourrissons qui ont fait une PCR dans les deux mois qui suivent la naissance.
NOUVEAU-NE DONT LE STATUT VIH EST POSITIF A 18 MOIS	Nombre de Nouveau-nés de mère séropositive, dont le test PCR du VIH s'est révélé positif à 18 mois.

8. SANTE DES MIGRANTS

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
PERSONNES MIGRANTES (FEMME / HOMME)	Toute personne qui n'est pas originaire du Maroc et qui vit de façon temporaire ou permanente au Maroc.

9. SOINS CURATIFS

Le système d'information de gestion des soins curatifs, est conçu pour être un outil qui aide les responsables des services d'action ambulatoire à mieux gérer les consultations curatives.

L'objectif visé par ce module est de mesurer le volume des différentes prestations sanitaires fournies, par les formations sanitaires à la population à desservir, au cours d'une période déterminée, par le biais d'un enregistrement quotidien des statistiques des consultations curatives médicales et prestations infirmières.

Les supports d'information de la consultation curative sont domiciliés au niveau de la cellule ou salle où s'effectue l'activité médicale ou (triage, soins, consultations) au niveau de chaque secteur ou de chaque centre de santé ou dans le cadre de l'équipe mobile.

9.1.Consultation curative

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
CONSULTATION CURATIVE	On entend par consultation curative, la prestation ou le soin dispensé aux individus ou aux familles de la communauté, dans les services de premier échelon ou de base c'est à dire « les ESSP». Ces prestations se subdivisent en deux catégories : - **Consultation curative médicale** faite par un médecin généraliste ou spécialiste ou médecin de famille. - **Prestation Infirmière** est celle effectuée par un personnel infirmier, au niveau des postes de triage ou aux salles de soins (pansement, injection, examens systématiques). ***Remarque :*** *La consultation curative concerne aussi bien les épisodes de maladies aiguës que ceux des maladies chroniques. Chaque épisode est considéré comme un nouveau cas au moment où il est identifié. Un même patient peut donc être considéré plusieurs fois NC pour des épisodes différents.* Au cas où un patient présente simultanément plus d'un problème de santé, il sera comptabilisé une seule fois comme NC.
SOINS CURATIFS	Les soins curatifs sont des soins offerts à toute personne ayant le besoin de soulager sa souffrance ou chez qui le processus morbide nécessite une prise en charge. Dans certaines situations, les soins curatifs prennent un caractère préventif. C'est le cas du diabète où les soins qui sont fournis à un diabétique pour empêcher la survenue de complications à long terme prennent un caractère préventif.
NOUVEAU CAS	Tout patient qui bénéficie de soins curatifs concernant un épisode de maladie aiguë ou chronique, à l'occasion de sa première identification.

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
ANCIEN CAS	Tout patient qui bénéficie de soins curatifs concernant un épisode de maladie aiguë ou chronique, à l'occasion d'une prise en charge. Cette prise en charge postérieure à celle qui a permis son identification est justifiée par la nature de la maladie qui nécessite plus d'une intervention curative
REFERENCE	C'est une notion qui implique le recours à un service plus qualifié que celui qui a référé pour la prise en charge d'un problème de santé donné. Par exemple, la référence du dispensaire au centre de santé ou bien du centre de santé à l'hôpital. Trois types de références sont envisagés : - Référence urgente: qui ne permet pas de délai. - Référence pour Consultations spécialisées: Cette catégorie regroupe les références nécessitant une prise en charge par le niveau supérieur. - Référence pour Bilan complémentaire.

9.2.Infertilité du couple

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
NOUVEAU COUPLE	Le couple ayant consulté pour la première fois pour un problème de fertilité.
ANCIEN COUPLE	Le couple ayant consulté lors d'une visite de suivi pour un problème de fertilité.
INFERTILITE PRIMAIRE	l'incapacité d'un couple à avoir un 1er enfant
INFERTILITE SECONDAIRE	la difficulté d'un couple à avoir un autre enfant alors qu'ils en ont déjà conçu un ou ont déjà eu un avortement.
CAUSE MASCULINE	l'infécondité est d'origine masculine
CAUSE FEMININE	l'infécondité est d'origine féminine
CAUSE MASCULINE ET FEMININE	l'infécondité est partagée, elle est d'origine féminine et masculine
IDIOPATHIQUE	**L'infertilité idiopathique** c'est quand on ne trouve pas de cause pour l'expliquer après l'interrogatoire du médecin.
REFERENCE	Couple ayant un problème de fertilité référé pour un bilan biologique, radiologique, avis spécialisé,…

9.3.Santé mentale

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
DEPRESSION	La dépression se manifestations habituellement par les symptômes suivants : • Multiples symptômes physiques persistants sans cause apparente • Faible énergie, fatigue, problèmes de sommeil • Tristesse ou humeur dépressive persistante, anxiété • Perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités habituellement agréables. **Le diagnostic est posé** si le patient présente pendant 2 semaines et plus : 1) Au moins un des symptômes principaux de dépression (Humeur dépressive persistante ; Intérêt ou plaisir fortement diminué dans les activités); 2) Plusieurs des symptômes additionnels suivants : – Sommeil perturbé ou excès de sommeil – troubles de l'appétit ou du poids (augmentation ou diminution) – Sentiment d'inutilité ou de culpabilité – Fatigue ou perte d'énergie – Concentration réduite – Indécision – Agitation ou nervosité physique observable – Parle ou bouge plus lentement que d'habitude – Désespoir – Pensées ou actes suicidaires
PSYCHOSES	Les psychoses se manifestent habituellement par les symptômes suivants : - Changements marqués du comportement, avec une négligence des responsabilités habituelles liées au travail, à l'école, aux activités domestiques ou sociales. - Agitation, comportement agressif, augmentation ou diminution de l'activité. - Croyances erronées inébranlables, non partagées par l'entourage culturel de l'individu. - hallucinations : le patient entend des voix ou voit des choses qui ne sont pas réelles. - Absence de prise de conscience de

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
	présenter des troubles mentaux. Pour poser le diagnostic de psychose, la personne doit avoir au moins deux des manifestations suivantes: – Délires : croyances erronées inébranlables et non partagées par d'autres dans la culture de l'individu – Hallucinations : entend des voix ou voit des choses qui ne sont pas réelles – Discours et/ou comportement désorganisé, ex : discours incohérent/hors-sujet, soliloques, rires sans justification, apparence étrange, signes de laisser-aller ou d'apparence négligée
TROUBLE ANXIEUX	Les troubles anxieux se traduisent par une anxiété forte et durable sans lien avec un danger ou une menace réelle, qui perturbe le fonctionnement normal et les activités quotidiennes de la personne. Il existe plusieurs types de troubles anxieux : l'anxiété généralisée, le trouble panique, les phobies spécifiques, l'agoraphobie, le trouble d'anxiété sociale et le trouble d'anxiété de séparation. Leurs symptômes, très variables d'une personne à l'autre de nature : • Psychologiques : irritabilité, impulsivité, peur irrationnelle, difficulté à se concentrer, baisse des performances intellectuelles, incapacité à faire des projets, vision négative de l'avenir… • Physiques : troubles digestifs, douleurs, insomnies, fatigue, maux de tête, vertiges… Ces troubles entraînent progressivement des comportements d'évitement du danger potentiel : refus de se rendre dans certains lieux, d'effectuer certaines actions, de rencontrer les autres…
TROUBLE DU COMPORTEMENT, DU DEVELOPPEMENT ET EMOTIONNEL CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT	**Les Troubles du développement** se manifestent par : - Difficulté à réaliser les activités quotidiennes normales de son âge ; difficulté à comprendre les instructions ; - Difficultés dans les interactions sociales et à s'adapter aux changements ; - Difficultés ou bizarreries dans la communication ; - Comportements répétitifs ou stéréotypés, - Centres d'intérêt et activités restreints D'autres symptômes selon l'âge : *Enfant de moins de 5ans* : Retard staturo-pondéral, faible tonus musculaire, retard dans les acquisitions du développement selon l'âge (ex : premier sourire, position assise, interaction avec d'autres, attention partagée, marche, parole, contrôle des sphincters) ; *Enfant de 6 -12 ans* : - Retard dans la lecture, l'écriture

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
	- Retard pour s'habiller seul, se laver, se brosser les dents *Adolescent de 13-18 ans* : - Mauvaises performances scolaires - Difficulté à comprendre les instructions - Difficultés dans les interactions sociales et difficulté à s'adapter aux changements. **Troubles du comportement** Chez les enfants de 4-18 ans ces troubles se manifestent par : – Hyperactivité : court partout de manière excessive, extrême difficulté à rester assis, parle excessivement ou bouge sans cesse ; – Inattention marquée, manque de concentration, arrête sans cesse une tâche avant d'avoir terminé et passe à autre chose – Impulsivité excessive : agit souvent sans réfléchir – Comportements fréquents et répétés qui dérangent les autres (ex : colères violentes et fréquentes, comportements cruels, désobéissance importante et persistante, vols) – Brusques changements de comportement ou dans les relations avec les pairs, incluant mise en retrait et colère. **Les troubles émotionnels** Les troubles émotionnels se manifestent par : - Craintes excessives, anxiété, évitement de certaines situations ou objets (ex : séparation avec les parents, situations sociales, certains animaux ou insectes, peur de la hauteur, des espaces confinés, de la vue du sang ou des blessures) – Changements dans les habitudes de sommeil et alimentaires – Intérêt et participation diminués pour les activités – Comportements d'opposition ou pour attirer l'attention.
AUTRES TROUBLES MENTAUX , NEUROLOGIQUES ET LIES A L'USAGE DE SUBSTANCES (TROUBLES MNS)	Les autres troubles MNS comprennent : - la démence ; - les troubles liés à l'usage de substances ; - l'épilepsie, - les conduites auto-agressives / Suicidaires

9.4.RAA

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
NOUVEAU CAS DE RAA DIAGNOSTIQUE	Nouveaux cas RAA diagnostiqués (confirmés) Le RAA est une réaction auto-immune inflammatoire systémique tardive, qui apparaît 2 à 4 semaines après une pharyngite à Streptocoque du Groupe A (SGA) non traitée.
NOUVEAU CAS DE MCR PRIMITIVES DIAGNOSTIQUES	Nouveaux cas MCR diagnostiquées (confirmées) (d'emblée diagnostiquées MCR sans épisodes ultérieurs de RAA (qui est passé inaperçu)).
CAS DE MCR SECONDAIRES DIAGNOSTIQUES	Nombre de cas de RAA suivis ayant développés des MCR secondaires Les MCR sont définit comme un groupe de troubles cardiaques de courte durée (aigus) ou de longue durée (chroniques) qui peuvent survenir à la suite d'un RAA. Ces troubles peuvent survenir plusieurs années après la maladie initiale.

9.5.Violence

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
FORMES DE VIOLENCE A L'EGARD DES FEMMES ET DES ENFANTS	- Violence physique - Violence sexuelle
CERTIFICAT MEDICALE POUR CAS DE VIOL	

10. SUIVI DES MALADIES CHRONIQUES – DIABETE ET HTA-

Cas suivi pour maladie chronique : Tout cas qui se présente à la consultation médicale sur rendez-vous conformément à la stratégie de prise en charge ou spontanément suite à une souffrance liée à une maladie chronique pour laquelle le patient est suivi. Il s'agit ici des maladies chroniques pour lesquelles il existe un programme structuré telles la bilharziose, la lèpre, la tuberculose, ou des maladies chroniques relativement fréquentes telles que le diabète, l'hypertension, les cardiopathies etc…

10.1. Diabète

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
NOUVEAU CAS	Tout patient qui est diagnostiqué diabétique pour la première fois durant l'année en cours(de janvier à décembre) quel que soit le lieu où le secteur de diagnostic de sa maladie (privé ou public)
ANCIEN CAS	Tout patient diagnostiqué avant l'année en cours pour diabète quel que soit le lieu où le secteur de diagnostic et /ou de suivi de sa maladie.

10.2. HTA

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
HTA	- On parle d'une hypertension artérielle si Pression Artérielle est supérieure ou égale à 140/90 ; - Chez le diabétique : si pression artérielle est supérieure ou égale à 130/80 mm Hg. (Ref : RBPM HTA 2012)
NOUVEAU CAS	Tout patient qui est diagnostiqué hypertendu pour la première fois durant l'année en cours(de janvier à décembre) quel que soit le lieu ou le secteur de diagnostic de sa maladie (privé ou public)
ANCIEN CAS	Tout patient diagnostiqué avant l'année en cours pour HTA quel que soit le lieu où le secteur de diagnostic et /ou de suivi de sa maladie.

10.3. Complication

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
COMPLICATION ET RISQUE CARDIO VASCULAIRE	Diabétiques compliqués : Diabétiques ayant développés une complication aigu ou chronique. HTA compliqués : Les hypertendus ayant développés une complication. RCV≥30% : C'est-à-dire que la personne âgée de 40 ans et plus a 30% de risque de développer un évènement cardiovasculaire fatal ou non fatal dans les 10 ans à venir (Très haut cardiovasculaire :RCV ≥30%) (Réf : Guide d'évaluation et de prise en charge du risque cardiovasculaire -DELM 2018)
DIABETIQUE COMPLIQUES	Diabétiques ayant développés une complications aigus ou chroniques.
HTA COMPLIQUES	Les hypertendus ayant développés une complication.
RCV ≥ 30%	RCV≥30% : C'est-à-dire que la personne âgée de 40 ans et plus a 30% de risque de développer un évènement cardiovasculaire fatal ou non fatal dans les 10 ans à venir (Très haut cardiovasculaire :RCV ≥30%) (Réf : Guide d'évaluation et de prise en charge du risque cardiovasculaire -DELM 2018)
COMPLICATIONS AIGUES	Coma acido-cétosique ; Coma hypoglycémique
CORONAROPATHIE	La coronaropathie est une maladie cardiovasculaire qui atteint les artères coronaires, dont le calibre est rétréci par la présence de plaques athéromateuses dans leurs parois.
AVC	L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit l'Accident Vasculaire Cérébral (AVC) comme une conséquence de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau. L'AVC peut avoir pour origine une obstruction d'un vaisseau sanguin (AVC Ischémique) ou une rupture de celui-ci (AVC Hémorragique)
COMA HYPOGLYCEMIQUE	-Tout coma dû à une hypoglycémie (la mesure sur sang veineux de la glycémie : le seuil le plus souvent admis est à 0,50 g/L (2,75 mmol/l). -Tout trouble de la conscience chez un diabétique traité par l'insuline ou sulfamides hypoglycémiants doit être considéré comme hypoglycémique jusqu'à preuve du contraire.
ACIDOCETOSE DIABETIQUE	Coma dû à une hyperglycémie (avec une hyperglycémie> 2,5 g/l, une glycosurie, une cétonurie ≥ à ++) avec les signes cliniques et biologiques d'une acidocétose.
COMPLICATION CHRONIQUES	Néphropathie ; Neuropathie ; Rétinopathie ; Pied diabétique ; Coronaropathie ; AVC.
NEPHROPATHIE	La néphropathie est une glomérulopathie qui fait partie des complications

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
	de la micro angiopathie et dont la première manifestation clinique est l'augmentation de la micro albuminurie.
NEUROPATHIE	La neuropathie est une atteinte d'un ou de l'ensemble des nerfs du système nerveux périphérique. A l'origine de paresthésies (fourmillements, picotements...), elle peut conduire à la paralysie.
RETINOPATHIE	La rétinopathie est une complication de la micro angiopathie, c'est la première cause de cécité.
PIED DIABETIQUE	Présence de lésion même minime au niveau du pied du patient diabétique, elle peut passer inaperçue, s'infecter et aboutir à une amputation. C'est un pied à risque nécessitant des soins et une éducation.

10.4. Traitement

CONCEPTS	DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
MHD seules	Régime alimentaire adapté, individualisé, et équilibré. -Réduction de la consommation des graisses saturées et des glucides. -Réduction de la consommation de sel (NaCl) à moins de 5 g/j. -Pratique d'une activité physique régulière, adaptée à l'état clinique du patient, d'au moins 30 min, 3 fois par semaine.
Insulinothérapie seule	Malades diabétiques sous traitement par insuline seule.
ADO seule	Malades diabétiques sous antidiabétiques oraux seuls.
Insuline + ADO	Malades diabétiques sous insuline et antidiabétiques oraux.
Statines	Médicament faisant partie d'une classe d'hypolipidémiants, utilisés pour baisser la cholestérolémie de personnes qui risquent de développer une maladie cardiovasculaire
Aspirine à faible dose	L'aspirine à faible dose empêche les plaquettes, des éléments du sang, de s'agréger entre elles et de former un caillot à l'intérieur des vaisseaux. Elle est prescrite chez les personnes à haut risque cardiovasculaire pour prévenir les maladies cardiovasculaires (MCV), notamment l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux (AVC), et également chez les patients qui ont déjà eu un épisode d'AVC ou d'attaque cardiaque, afin de prévenir les récidives
Monothérapie	Le malade est sous un seul médicament antihypertenseur.
Bithérapie	Le malade est sous une association de deux médicaments antihypertenseurs.
Trithérapie	Le malade est sous une association de trois médicaments antihypertenseurs.